

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

GLOBAL RAPPORT

Genetische onderzoeken

Prenatale opsporing van trisomieën 13/18/21-NIPT

ENQUETE 2026/2

* KB 03/12/1999

* KB 05/12/2011

Sciensano/Moleculaire biologie-Genetische onderzoeken-NIPT16/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
J. Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be



EXPERTENCOMITE

Sciensano			
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22
		FAX:	02/642.56.45
		e-mail	ql_secretariat@sciensano.be
Joséphine Lantoine	Enquêtecöördinator	TEL:	02/642 53 94
		e-mail:	Josephine.lantoine@sciensano.be
Bernard China	Vervanger enquêtecöördinator	TEL:	02/642 52 08
		e-mail:	bernard.china@sciensano.be
Vanessa Ghislain	Vervanger enquêtecöördinator	TEL:	02/642 53 85
		e-mail:	Vanessa.ghislain@sciensano.be
Experten	Instelling		
Ina Benoy	Rode Kruis		
Elke Boone	AZ Delta		
Cécile Colpaert	UZ Leuven		
Barbara Depreter	AZ Delta		
Evelien Heylen	ZNA		
Marie LeMercier	UZA		
Freya Vaeyens	UZ Brussel		
Jacques Van Huysse	AZ Sint Jan Brugge		

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op 28/04/2026.

Dit rapport werd besproken per email.

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport: door Joséphine Lantoine, enquêtecöördinator

Publicatiedatum : 26/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-moleculaire-biologie-hemato-oncologie>

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL

1	STALEN	4
2	DEELNEMERS.....	4
3	RESULTATEN.....	4
3.1	Resultaten per staal	5
3.2	Resultaten per laboratorium.....	7
3.3	Commentaren	12
4	GEBRUIKTE METHODES	12
5	CONCLUSIES OVER DE RESULTATEN VAN DE LABORATORIA	13
	INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT	14

1 Stalen

De stalen zijn 1ml gesimuleerd plasma (Matribase) met ingekapseld foetaal DNA (cfDNA concentratie= 31.6 ng/μl). De foetale fractie is geschat op 7.5%. Het is een commercieel staal van de firma Seracare (37 Birch St, Milford, MA 01757, USA) dat in België door de firma Sopachem (Nieuwe Steenweg 20A 9810 Nazareth BE) verdeeld wordt.

De stalen werden naar de laboratoria gestuurd met het aanvraagformulier voor de NIPT test van het laboratorium.

2 Deelnemers

16 klinische biologie laboratoria waren voor deze enquête ingeschreven.

Slechts één laboratorium heeft niet gereageerd, omdat de analyse momenteel binnen het laboratorium wordt gevalideerd. We herinneren de laboratoria eraan dat het in het kader van de validatie van een analyse beter is om een staal aan te vragen buiten de kwaliteitscontrole dan, om zich in te schrijven – zeker als het de bedoeling is om geen resultaten voor de controles in te dienen.

4 laboratoria hebben de analyse uitbesteed aan een centrum menselijke erfelijkheid en 1 laboratorium aan een ander laboratorium van klinische biologie.

3 Resultaten

Elk laboratorium heeft één of twee stalen met ingekapseld DNA ontvangen. Het aantal stalen is afhankelijk (i) van de resultaten van de preliminaire bevraging over de gebruikte methode en de nodige DNA-hoeveelheid die we in 2021 naar de deelnemers gestuurd hebben en (ii) van de commentaren van de vorige enquêtes.

We hebben gevraagd aan de laboratoria om de aanwezigheid van trisomieën met moleculaire methodes op te sporen. Naast het antwoordformulier dat i) precisering van de gebruikte methode; ii) de teruggevonden foetale fractie en iii) de aanvaardbaarheidscriteria voor NIPT stalen in routine bevroeg, hebben we aan de laboratoria ook gevraagd het klinisch rapport van de analyse van het staal toe te voegen.

3.1 Resultaten per staal

3.1.1 Interpretatie

Hieronder worden de verschillende interpretaties getoond die de laboratoria weergegeven hebben in het klinische rapport van de patiënt:

Staal	Verwachte resultaten	Vastgestelde resultaten	Aantal laboratoria (%)
<u>NIPT2026</u>	Laag risico voor Trisomie 13 Hoog risico voor Trisomie 18 Laag risico voor Trisomie 21	Laag risico Trisomie 13 Hoog risico Trisomie 18 Laag risico Trisomie 21	5 (33,3)
		Normaal voor Trisomie 13 Hoog risico voor Trisomie 18 Normaal voor Trisomie 21	5 (33,3)
		Lage waarschijnlijkheid voor Trisomie 13 Grote waarschijnlijkheid voor Trisomie 18 Lage waarschijnlijkheid voor Trisomie 21	1 (6,7)
		Hoog risico op afwijkingen aan de autosomen XY,+13,+18	1 (6,7)
		Normaal voor Trisomie 13 Niet conclusief voor Trisomie 18 Normaal voor Trisomie 21	2 (13,3)
		geen analyse NIPT uitgevoerd door te weinig foetaal cfDNA	1 (6,7)

3.1.2 Verplichting van een bevestiging met een invasieve test

De verplichting van een invasieve test wegens “Hoog risico Trisomie 18” of “niet conclusief voor Trisomie 18” werd vermeld door 100% van de laboratoria die een klinisch rapport hebben gestuurd (14/14).

3.1.3 Geslacht van de foetus

Alle laboratoria die een klinisch rapport hebben ingediend en die de analyse kunnen uitvoeren (14/14) hebben het juiste geslacht van de foetus vermeld, namelijk mannelijk. In de aanvragen voor de analyses werd inderdaad ook gevraagd om het geslacht van de foetus te bepalen.

3.1.4 Informatie over de limieten van de test

In dit verband wordt rekening gehouden met de duidelijke vermelding dat de NIPT-test een screeningstest is en geen diagnostische test, evenals met de vermelding van factoren die tot een onjuist of niet interpreteerbaar resultaat kunnen leiden.

Slechts één laboratorium heeft niet duidelijk vermeld dat de NIPT geen diagnostische test is, maar een screeningstest, en evenmin de factoren die tot foutieve of niet-interpreteerbare resultaten kunnen leiden, zoals vermeld in de richtlijnen van de BeSHG.

We benadrukken de verbetering van de klinische rapporten van de laboratoria op dit vlak, gezien de drastische daling van het aantal laboratoria dat dit niet vermeldt.

Een evaluatie van de administratieve nauwkeurigheid van de gegevens van het rapport werd ook gedaan:

3.1.5 Identificatie van het patiënt

Hieronder de identificatie van de patiënt zoals vermeld door de laboratoria op het rapport:

Staal	Verwachte identificatie	Vastgestelde identificatie	Aantal laboratoria (%)
NIPT2026	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	10 (66,7)
		Adèle Blauc-sec 06/06/2000	5 (33,3)

Houd er rekening mee dat de laboratoria die Adèle Blauc-sec hebben geregistreerd, geen sancties hebben gekregen omdat de aanvragen voor analyses met de hand zijn ingevuld en niet via een etiketteringssysteem, zoals gebruikelijk is.

3.1.6 Zwangerschapsduur

Hieronder worden de verschillende draagtijden (op het moment van de afname) en/of de verwachte bevallingsdatum weergegeven die door de laboratoria in het klinisch rapport zijn vermeld:

Staal	Verwachte resultaten	Vastgestelde resultaten	Aantal laboratoria (%)
NIPT2026	13w 5d 09/09/2026	13w 5d en 09/09/2026	5 (33,3)
		13w 5d	8 (5,3)
		09/09/2026	1 (6,7)
		Niet vermeld	1 (6,7)

NB: Het volstaat om de zwangerschapsduur of de uiterekende datum te vermelden.

3.1.7 Afnamedatum en afname tijdstip

Hieronder worden de verschillende rapporteringen van de afname datum en het afname tijdstip getoond:

Staal	Verwachte afname datum en tijdstip	Op de rapporten	Aantal laboratoria (%)
NIPT2026	09/03/2026 10 :00	Correcte afname datum en tijdstip	12 (80)
		Correcte afname datum en tijdstip niet vermeld	2 (13,3)
		Onjuiste afname datum en tijdstip	1 (6,7)

3.1.8 Datum van uitgave van het rapport

Alle laboratoria hebben de datum van uitgave van het rapport vermeld.

3.2 Resultaten per laboratorium

3.2.1 Evaluatie van genotypering en interpretatie

Lab	Gebruikte methodologie		Vastgesteld resultaat	Geslacht van de foetus	Verplichting van invasieve test	Limieten van de analyse	Score
	Technologie/apparaat	Kit					
1	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Hoog risico Trisomie 18; Laag risico Trisomie 13; Laag risico Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
2	NGS-Nextseq 500-Illumina	IONA-Yourgene	Hoog waarschijnlijkheid Trisomie 18; Lage waarschijnlijkheid Trisomie 13; Lage waarschijnlijkheid Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
3	NVT		Geen resultaten gestuurd. Nieuwe analyse in validatie.		NVT	NVT	niet geslaagd
4	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Hoog risico op afwijkingen aan de autosomen XY,+13,+18	mannelijk	JA	Screening test vs diagnostische test niet duidelijk vermeld. Ontbrekende elementen	niet geslaagd
5	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Verhoogd risico voor Trisomie 18; Geen verhoogd risico voor Trisomie 13; Geen verhoogd risico voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
6	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Afwijkend Trisomie 18-verhoogd risico voor Trisomie 18; Geen verhoogd risico voor Trisomie 13; Geen verhoogd risico voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd

Lab	Gebruikte methodologie		Vastgestelde T21	Geslacht van de foetus	Verplichting van invasieve test	Detectie limitaties	Score
	Technologie/apparaat	Kit					
7	shallow WGS-Hiseq/Novaseq-Illumina	NIPT-PLUZ	Afwijkend Trisomie 18- Trisomie 18 waarschijnlijk; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA (+NIPT PLUZ UZLeuven website)	geslaagd
8	shallow WGS-Novaseq Xplus-Illumina	NIPT-PLUZ	Niet conclusief voor Trisomie 18; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA voor de zekerheid van aanwezigheid of afwezigheid van T18	JA (+NIPT PLUZ UZLeuven website)	geslaagd
9	shallow WGS-Novaseq Xplus-Illumina	NIPT-PLUZ	Niet conclusief voor Trisomie 18; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA voor de zekerheid van aanwezigheid of afwezigheid van T18	JA (+NIPT PLUZ UZLeuven website)	geslaagd
10	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Hoog risico Trisomie 18; Laag risico Trisomie 13; Laag risico Trisomie 21	mannelijk	JA	JA (labogids + patientbrochure)	geslaagd
11	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Verhoogd risico voor Trisomie 18; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
12	Microarray-Harmony-Roche Ariosa Diagnostics	Harmony prenatal test-Roche Ariosa Diagnostics	geen analyse NIPT uitgevoerd door te weinig foetaal cfDNA		NVT	NVT	Niet evalueerbaar
13	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Hoog risico Trisomie 18; Laag risico Trisomie 13; Laag risico Trisomie 21	mannelijk	JA	JA (labogids)	geslaagd

Lab	Gebruikte methodologie		Vastgestelde T21	Geslacht van de foetus	Verplichting van invasieve test	Detectie limitaties	Score
	Technologie/apparaat	Kit					
14	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Afwijkend Trisomie 18-Verhoogd risico voor Trisomie 18; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
15	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina + Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Afwijkend Trisomie 18-Verhoogd risico voor Trisomie 18; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA	geslaagd
16	shallow WGS-Novaseq 6000-Illumina	NIPT-PLUZ	Afwijkend Trisomie 18-Trisomie 18 waarschijnlijk; Normaal voor Trisomie 13; Normaal voor Trisomie 21	mannelijk	JA	JA (+ (NIPT-PLUZ leuven website)	geslaagd

*niet library preparation kit

3.2.2 Evaluatie van de administratieve nauwkeurigheid

Lab	Identificatie van de patiënt : Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Zwangerschapsduur 13w 5d	Verwachte bevallingsdatum 09/09/2026	Afname datum en tijdstip 09/03/2026 10:00	Vermelding van rapport datum	Score
1	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	13/03/2026	geslaagd
2	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13w 5d	09-09-26	10/03/2026 11.49	16/03/2026	niet geslaagd
3	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	niet geslaagd
4	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	niet vermeld	niet vermeld	09/03/2026 10.00	25/03/2026	aanvaard baar
5	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	23-03-26	geslaagd
6	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	30-03-26	geslaagd
7	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13w 5d	09/09/2026	09/03/2026 10.00	18-03-26	geslaagd
8	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13w 5d	09/09/2026	09/03/2026 10.00	07-04-26	geslaagd
9	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13w 5d	09/09/2026	09/03/2026 10.00	07-04-26	geslaagd
10	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	19-03-26	geslaagd
11	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	09/09/2026	09/03/2026 niet vermeld	02/04/2026	niet geslaagd
12	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 niet vermeld	08/04/2026	niet geslaagd
13	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	13/03/2026	geslaagd

	Identificatie van de patiënt : Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Zwangerschapsduur 13w 5d	Verwachte bevallingsdatum 09/09/2026	Afname datum en tijdstip 09/03/2026 10:00	Vermelding van rapport datum	Score
Lab						
14	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	23/03/2026	geslaagd
15	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13w 5d	niet vermeld	09/03/2026 10.00	01/04/2026	geslaagd
16	Adèle Blauc sec 06/06/2000	niet vermeld	09/09/2026	09/03/2026 10.00	31/03/2026	geslaagd

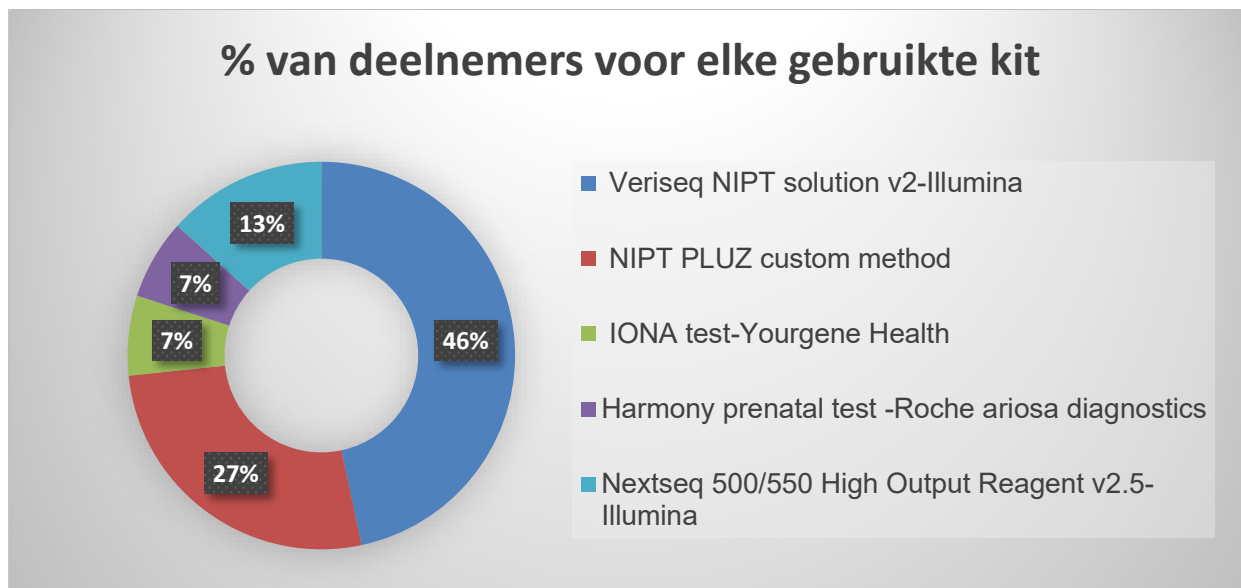
3.3 Commentaren

- Eén laboratorium heeft een onvoldoende score behaald voor het onderdeel genotypering en interpretatie, omdat het naast trisomie 18 ook een hoog risico op trisomie 13 voor de foetus heeft aangegeven.
- Wat betreft de limieten van de NIPT-test, raden wij laboratoria aan de richtlijnen van de BeSHG te volgen. Wij raden aan om aan te geven welke factoren kunnen leiden tot een foutief of niet-interpreteerbaar resultaat en om duidelijk te vermelden dat de NIPT-test een screening test is en geen diagnostische test is.
- We constateren een zeer duidelijke verbetering wat betreft de vermelding van de zwangerschapsduur. Slechts één laboratorium heeft namelijk noch de zwangerschapsduur, noch de uitgerekende datum in zijn klinisch rapport vermeld; dit in tegenstelling tot het onderzoek van 2025, toen dit laboratorium de zwangerschapsduur wel in zijn rapport vermeldde. Dit laboratorium heeft daarom een aanvaardbare score behaald voor het administratieve gedeelte.
- Twee laboratoria hebben het tijdstip van de afname niet vermeld in het klinisch rapport. Dit wordt echter wel duidelijk vermeld en gevraagd op het aanvraagformulier voor analyse. De praktijkrichtlijn voor klinische biologie (punt 7.4.1.6 van de richtlijn – versie 4; 2025) bepaalt echter dat het klinisch rapport de datum en het tijdstip van de afname moet vermelden wanneer deze bekend zijn. Deze laboratoria kregen daarom een onvoldoende voor het administratieve gedeelte.
- Aangezien verschillende laboratoria geen sluitend resultaat konden verkrijgen of de analyse zelfs niet konden uitvoeren, hebben we contact opgenomen met het firma die de stalen geproduceerd heeft. Het staal is door de firma gevalideerd en de foetale fractie is geschat met de Veriseq-kit van Illumina. Aangezien twee van de vier laboratoria die de analyse aan hetzelfde genetisch centrum hadden uitbesteed een niet-conclusief resultaat hebben verkregen, zullen we contact opnemen om te informeren naar de extractiemethode van deze laboratoria en de door het genetisch centrum gebruikte pijplijn. De firma heeft ons bevestigd dat verdunning van het staal mogelijk is, maar uitsluitend met PBS en met hun verdunningsmiddel (SeraCon Matribase Negative Diluent-Seracare).

4 Gebruikte methodes



Figuur 1 : Verdeling van laboratoria per gebruikte technieken voor de prenatale opsporing van trisomieën



Figuur 2 : Verdeling van laboratoria per gebruikte NGS kit voor de opsporing van trisomieën

De meest gebruikte techniek voor het opsporen van trisomieën via NIPT is de 'Veriseq NIPT solution v2' van Illumina waarbij er gesequenced wordt op een sequencer van het type 'Nextseq' (500-550(Dx)) » eveneens van Illumina.

Twee laboratoria hebben de kit « Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5 » van de firma Illumina vermeld. Houd er rekening mee dat dit kit geen « library preparation » kit is.

5 Conclusies over de resultaten van de laboratoria

De performanties van de verschillende laboratoria is bevredigend. Eén laboratorium heeft een onvoldoende score behaald voor het onderdeel genotypering en interpretatie, omdat het naast een trisomie 18 ook een hoog risico op trisomie 13 bij de foetus heeft gerapporteerd.

3 laboratoria hebben een onvoldoende score behaald voor het onderdeel administratieve nauwkeurigheid vanwege een onjuiste vermelding van de datum en/of het tijdstip van de afname. 1 laboratorium heeft een voldoende score behaald voor dit onderdeel omdat het geen zwangerschapsduur of uitgerekende datum heeft vermeld.

Wij verzoeken de laboratoria de richtlijnen van BeSHG en de praktijkrichtlijn voor klinische biologie opnieuw door te nemen.

We herinneren de laboratoria er ook aan dat we volgens ons intern beleid en ons kwaliteitssysteem het resultaat van de analyse die door elk laboratorium afzonderlijk ingevoerd niet kunnen wijzigen nadat de afsluiting van de enquête met als doel hun individuele rapport aan te passen. Alleen een fout die door ons is gemaakt, kan leiden tot een wijziging van een individueel rapport en dus van de score die aan het laboratorium is toegekend.

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport dat u via email gestuurd werd.

Hieronder vindt u de evaluatiecriteria waarop de evaluatie die u krijgt in uw individueel rapport gebaseerd is.

Evaluatiecriteria en bepaling van de toegewezen waarde

Het eerste evaluatiecriterium voor het onderdeel genotypering en interpretatie is de vermelding in het klinisch rapport van een hoog risico op trisomie 18 en dus van de noodzaak van een invasieve test.

Het hoge risico op trisomie 18 van het monster is gebaseerd op het commerciële certificaat dat door het bedrijf is verstrekt. De foetale fractie, geschat door de door het bedrijf uitgevoerde NGS-analyse, bedraagt 7,5%. In geval van ernstige afwijkingen tussen de resultaten van de laboratoria en de door het bedrijf uitgevoerde analyse (<2/3 van de deelnemers die de voorspelde trisomieën hebben gedetecteerd), zal het comité van deskundigen beslissen of de evaluatie al dan niet doorgaat.

Het tweede criterium is de vermelding van de beperkingen van de analyse, die de punten moeten bevatten die zijn uiteengezet in de richtlijnen van de BeSHG, met name het feit dat de NIPT een screeningstest is en geen diagnostische test, evenals de elementen die tot een foutief of niet interpreterbaar resultaat kunnen leiden.

Het derde criterium is de correcte vermelding van het geslacht van de foetus indien het gevraagd was op het aanvraagformulier.

Wat de administratieve nauwkeurigheid betreft, is het eerste criterium de correcte identificatie van de patiënte: NAAM/VOORNAAM/GEBOORTEDATUM.

Het tweede criterium betreft de correcte vermelding van de data en tijdstippen van de afname, evenals de vermelding van de publicatiedatum van het klinisch rapport.

Ten slotte is het derde criterium de vermelding van de correcte zwangerschapsduur of de verwachte bevallingsdatum.

U vindt hieronder de gebruikte scoring die door het comité van experts besproken en goedgekeurd werd:

1. Scoring voor de genotypering/interpretatie

Score	Resultaten van de genotypering	Invasieve test verplicht bij afwijkend NIPT resultaat	Limieten NIPT		Geslacht van de foetus	
			Screening test	Elementen die kunnen leiden tot een foutief of niet-conclusief resultaat	Indien gevraagd	Indien niet gevraagd
Geslaagd	V	V	V	V (rapport of labogids)	V	NV
Aanvaardbaar	V	V	NV	V/NV	V/NV	NV
Aanvaardbaar	V	V	V	NV	V/NV	NV
Niet Geslaagd	X	V/NV	V/NV	V/NV	V/NV	NV
Niet Geslaagd	V	NV	V/NV	V/NV	V/NV	NV
Niet Geslaagd	V	V	V	V (rapport of labogids)	X/NV	NV
Niet Geslaagd	V	V	V	V (rapport of labogids)	/	V/X

V = vermeld en correct; NV = niet vermeld; X = niet correct

2. Scorerooster voor de administratieve nauwkeurigheid

Score	Identificatie van de patiënte		Datum en tijdstip afname	Datum van rapport	Zwangerschapsleeftijd (weken-dagen) of verwachte bevallingsdatum
	Naam/Voornaam	GD (DD/MM/JJJJ)			
Geslaagd	V	V	V	V	V
Aanvaardbaar	V	V	V	V	X/NV
Niet geslaagd	NV/X	V/X/NV	V/X/NV	V/NV	V/X/NV
Niet geslaagd	V	NV/X	V/X/NV	V/NV	V/X/NV
Niet geslaagd	V	V	NV/X	V/NV	V/X/NV
Niet geslaagd	V	V	V	NV	V/X/NV

V = vermeld en correct; NV = niet vermeld; X = niet correct

Het geheel van de geëvalueerde/geanalyseerde punten in deze enquête is gebaseerd op verschillende Belgische en Europese richtlijnen zodat de kritische punten van het NIPT klinisch rapport kunnen geïdentificeerd worden. U vindt hieronder de referentie van deze documenten:

- BeSHG Prenatal Committee, NIPT good clinical practice guidelines. 2023
- Commissie voor klinische biologie-Werkgroep praktijkrichtlijn, PRAKTIJKRICHTLIJN VOOR HET OPZETTEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEM IN DE ERKENDE LABORATORIA VOOR KLINISCHE BIOLOGIE. 2025
- ISO15189:2022-Medical laboratories — Requirements for quality and competence

- Deans ZC. et al. Chapter 11: Best Practices for Integrating Cell-Free DNA-Based NIPT Into Clinical Practice, in Non Invasive Prenatal testing (NIPT). Lieve Page-Christiaens and Hanns-Georg Klein. 2018; 191–205
- Deans ZC, Allen S, Jenkins L, et al. Ensuring high standards for the delivery of NIPT world-wide: Development of an international external quality assessment scheme. Prenatal Diagnosis. 2019; 39:379–387

EINDE
